Intervenciones enfermeras de cuidado ocular en Cuidados Intensivos: revisión de revisiones (Umbrella Review)

Juan Gabriel Pérez González[1]
Francisco Javier Vega Vázquez[1]
[1]*Enfermero de UCI del Hospital Universitario Virgen Macarena (Sevilla)*

Introducción

El paciente crítico presenta una mayor predisposición a sufrir lesiones corneales al encontrarse comprometidos los mecanismos de protección ocular, que son principalmente la producción de lágrima y el reflejo de parpadeo. El bajo nivel de consciencia, el uso de sedantes y bloqueadores neuromusculares, la ventilación mecánica, la presencia de quemosis y el cierre incompleto de los párpados (lagoftalmos), entre otros factores, contribuyen a la incapacidad para mantener la lubricación adecuada del ojo y la potencial aparición de lesiones, asociadas al Síndrome del Ojo Seco. Estas lesiones, aunque mayoritariamente leves, pueden llegar a ser graves e irreversibles, hasta el punto de provocar una pérdida de visión al paciente.
La medición de la incidencia de lesiones oculares en pacientes ingresados en UCI se ha estimado en un 26% de daño en la superficie ocular en pacientes críticos adultos.

Objetivo

Recopilar y sintetizar la evidencia científica disponible en revisiones sistemáticas y metaanálisis sobre la efectividad de las distintas intervenciones enfermeras para la prevención de complicaciones oculares en el paciente crítico adulto.

Resultados

Se seleccionaron 7 artículos que cumplían los requisitos de búsqueda. Las intervenciones que aparecen en la revisión se basan en la lubricación ocular (en gotas, gel o pomada de lágrimas artificiales) y la colocación de una cámara aislante que genere un microambiente húmedo para evitar la evaporación de la lágrima.
Los colirios en gotas presentan menor eficacia debido a su rápida evaporación y su eliminación por el conducto nasolagrimal, por lo que necesita de aplicaciones muy frecuentes (cada 2 horas), lo que dificulta la adherencia al protocolo. Por el contrario, los geles y pomadas presentan mayor viscosidad por lo que mantienen la superficie ocular hidratada por periodos más prolongados (4-6 horas).
En cuanto a las cámaras de humedad, el film de polietileno es una medida con buena relación costo-efectiva y fácil de aplicar. Suele usarse una fina capa de pomada de vaselina en los bordes de la máscara para facilitar una mejor fijación y un correcto sellado, evitando así el uso de adhesivos que puedan dañar la piel al ser retirados de forma continuada.

PROPUESTA DE PLAN DE CUIDADOS ESTANDARIZADO

Diagnóstico NANDA: (245) **Riesgo de lesión corneal**

NOC: 1101- **Integridad tisular: piel y membranas mucosas**
Indicadores:
- (110125) **Abrasión corneal**

NIC: (1350) **Prevención de la sequedad ocular**
- Aplicar lagrimas artificiales en gel cada 6h.
- Colocar máscara de film transparente.
- Asegurar el cierre completo de los párpados.
(1650) **Cuidados de los ojos**
- Realizar limpieza periocular con agua destilada.
- Vigilar la aparición de signos y síntomas oculares anormales.

Bibliografía

ESCANEA EL QR

Autor y Año	Título	Estudios incluidos	Intervenciones enfermeras
Ni (2025)	Ocular Surface Disorders in ICU Patients: Evidence-Based Nursing Prevention Strategies	40	Las intervenciones que combinan la lubricación con la cobertura física (cámara de humedad) reducen significativamente las tasas de lesiones corneales.
Arevalo-Buitrago (2024)	Impact of nursing interventions on the prevention of ocular surface disorders in critical care patients: A systematic review	12	La lubricación con gel junto con la oclusión en cámara húmeda demostró ser la estrategia más eficaz para prevenir lesiones oculares en pacientes de UCI.
Askaryzadeh Mahani (2024)	The effect of polyethylene cover intervention on ocular surface disorder of intensive care unit patients: a systematic review and meta-analysis	10	Las máscaras de polietileno, los geles y las pomadas oftálmicas tuvieron similar efecto protector, mientras que las gotas oftálmicas y el cierre con esparadrapo fueron menos efectivas.
Do Prado (2023)	Nursing interventions to prevent corneal injury in critically ill sedated and mechanically ventilated patients: A systematic review of interventions	15	La lubricación ocular, preferiblemente en gel o pomada, y la protección de las córneas con una cámara de polietileno fueron las intervenciones más efectivas.
Yao (2021)	Comparative efficacy of various preventive methods for exposure keratopathy among critically ill patients: A network meta-analysis of randomized controlled trials	21	La pomada de lágrimas artificiales podría ser el mejor método de prevención (35%), seguido de la cámara de polietileno (31%), las gafas de natación (21%) y el apósito de espuma (18%).
Zhou (2014)	Moisture chamber versus lubrication for corneal protection in critically ill patients: a meta-analysis	7	El uso de cámaras de humedad se asocia con una protección corneal más efectiva en comparación con la lubricación.
Werli-Alvarenga (2013)	Nursing interventions for adult intensive care patients with risk for corneal injury: a systematic review	8	La mayoría de los estudios consideran que una cámara de humedad con máscara de polietileno es la mejor práctica.

Metodología

Se ha llevado a cabo una revisión de revisiones (Umbrella Review). Este diseño permite integrar los resultados de múltiples revisiones sistemáticas y metaanálisis relacionadas con el tema de estudio, aportando evidencia de alta calidad.

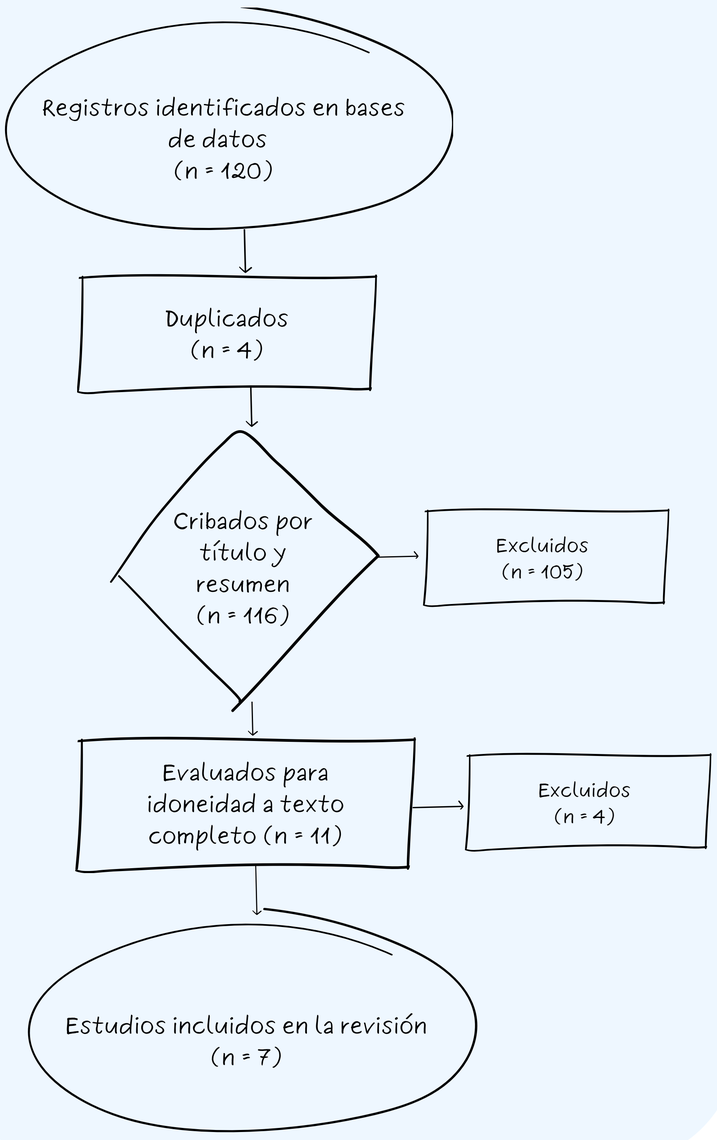
Criterios de inclusión/exclusión:
Inclusión:
- Revisiones sistemáticas con o sin metaanálisis sobre intervenciones de cuidado ocular.
- Población: Pacientes adultos ingresados en Cuidados Intensivos.
- Periodo: Desde 2010 a diciembre de 2025.

Exclusión
- Población pediátrica o neonatal.

Estrategia de búsqueda:
Se realizaron búsquedas en PubMed y SCOPUS durante la tercera semana de enero de 2026.

PubMed
("Eye care" OR "Exposure keratopathy" OR "Ocular surface disorders" OR "Corneal injury") AND ("intensive care" OR "critical care" OR "ICU")
Filtros aplicados: "Desde 2010 a la actualidad", "Systematic Review" y "Meta-Analysis".

SCOPUS
TITLE-ABS-KEY ("eye care" OR "exposure keratopathy" OR "ocular surface disorders" OR "corneal injury") AND ("intensive care" OR "critical care") AND PUBYEAR > 2009 AND PUBYEAR < 2026 AND (LIMIT-TO (LANGUAGE , "English")) AND (LIMIT-TO (DOCTYPE , "re"))



Conclusiones

La evidencia actual sitúa al abordaje combinado (cámara de humedad más lubricación en gel) como el "gold estándar" en el cuidado ocular del paciente crítico.
Existe ya en la bibliografía suficiente respaldo científico para adecuar las intervenciones de cuidado ocular en nuestras Unidades de Cuidados Intensivos a estas estrategias de protección.
En los estudios analizados también se refleja la importancia de la formación del personal de enfermería y el uso de protocolos estandarizados como la mejor manera de reducir la incidencia de lesiones oculares.